



ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DO SISTEMA DE SAÚDE, IP

OTIMIZAR RECURSOS
GERAR EFICIÊNCIA



Guia para elaboração de Programas Funcionais

G 09/2024



ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DO SISTEMA DE SAÚDE, IP

Guia para elaboração de Programas Funcionais G 09/2024

Ficha técnica

Número	G 09/2024
Data de aprovação	04/2024
Data de publicação	04/2024
Data última revisão	
Revisão obrigatória	

Equipa técnica

Autor	UIE/DRS/ACSS
Coordenação	UIE/DRS/ACSS
Edição	UIE/DRS/ACSS

Palavras-chave

Programa Funcional; Planeamento; PF; Dimensionamento

Resumo

O presente documento contém as orientações essenciais para a organização e estruturação de um Programa Funcional para planeamento de intervenções em unidades hospitalares existentes ou a construir. Inclui os principais pontos que devem ser desenvolvidos e clarificados no documento, lógica de organização e dimensionamento orientativo de alguns compartimentos mais comuns.

Base legal

Esta publicação é efetuada nos termos e para os efeitos da alínea r), do artigo 5º da Portaria nº 155/2012 de 22 de maio, tendo em atenção as atribuições da ACSS, IP previstas no artigo 3º do DL nº 35/2012 de 15 de fevereiro.

ISSN:

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio, salvo com autorização por escrito do editor, da parte ou totalidade desta obra.

Índice

1. OBJETIVO	11
2. ESTRUTURA DO PROGRAMA FUNCIONAL	11
3. ENQUADRAMENTO DA INTERVENÇÃO NA ULS	12
4. ENQUADRAMENTO DA INTERVENÇÃO NA UNIDADE HOSPITALAR	12
5. ÁREA DE INFLUÊNCIA E PERFIL ASSISTENCIAL	13
5.1. ÁREA DE INFLUÊNCIA	13
5.2. PERFIL ASSISTENCIAL	13
6. REQUISITOS MÍNIMOS DE CAPACIDADE	15
7. PRINCÍPIOS ORIENTADORES	16
7.1. ORIENTAÇÃO PARA O UTENTE	16
7.2. CENTRALIZAÇÃO E PARTILHA DE RECURSOS	16
7.3. FLEXIBILIDADE E EXPANSÃO FUTURA	17
7.4. EXTERNALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CLÍNICOS	17
7.5. SUSTENTABILIDADE	18
7.6. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	18
7.7. DIFERENCIAÇÃO DE CIRCUITOS	19
7.8. ENTRADAS/SAÍDAS DA UNIDADE HOSPITALAR	19
7.9. SEGURANÇA DOS UTENTES E PROFISSIONAIS	20
7.10. ELEVADOS NÍVEIS DE DISPONIBILIDADE E FIABILIDADE	21
7.11. HUMANIZAÇÃO DO AMBIENTE HOSPITALAR	21
7.12. PARTILHA DE RECURSOS ENTRE AS ATIVIDADES DE ENSINO E ENTRE AS ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	21
7.13. INTEGRAÇÃO DO HOSPITAL NA REDE DE CUIDADOS DE SAÚDE	22
8. ORGANIZAÇÃO DO HOSPITAL: ÁREAS E ESPAÇOS FUNCIONAIS	22
8.1. ÁREAS FUNCIONAIS	22
8.2. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FUNCIONAL (EF)	26
9. PLANO DE ÁREAS	26
10. ÁREAS DE COMPARTIMENTOS MAIS COMUNS	28
11. CÁLCULO DE ÁREAS DE COMPARTIMENTOS DEPENDENTES DE Nº DE UTILIZADORES	31
12. MATRIZ DE PROXIMIDADES	32
13. ESTACIONAMENTOS	34
13.1. ESTACIONAMENTO DE SUPERFÍCIE	34
13.2. ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO	35
14. BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA	36

Preâmbulo

A publicação deste Guia para Elaboração de Programas Funcionais impõe-se devido à inexistência de orientações em Portugal sobre esta temática, sobretudo face ao número crescente de “programas funcionais” que, ao longo dos anos, têm chegado à Unidade de Instalações e Equipamentos da ACSS, IP para análise e validação, todos eles com diferentes abordagens à organização hospitalar e com estruturas díspares que invalidam a comparabilidade entre documentos.

Por outro lado, a análise e comparação, das instalações hospitalares é fundamental para o respetivo estudo e otimização de soluções. Esta análise é, no entanto, grandemente dificultada pela falta de uniformização que se constata nos documentos que vêm sendo produzidos, nomeadamente nos programas funcionais (PF).

Na sequência desta evidência, importa agora publicar um documento que vise a uniformização dos critérios para a elaboração desse documento fundamental, que integre uma uniformização organizativa e terminológica, documento essencial para a elaboração de projetos e a base de qualquer intervenção que se venha a fazer numa unidade hospitalar, o **Programa Funcional**.

Um programa funcional é um documento essencial para os projetistas, faz parte de todo o processo de planeamento anterior ao desenvolvimento do projeto e constitui necessariamente um trabalho moroso onde estão envolvidos uma grande diversidade de profissionais e onde se devem estabelecer todos os parâmetros pretendidos no que respeita às infraestruturas, e aos respetivos organização, funcionamento e princípios orientadores. Deve, por isso, ser um documento o mais detalhado possível, obrigando a uma reflexão sobre o hospital existente e o hospital que se pretende e a forma como se vão atingir esses objetivos, tendo em vista uma unidade de saúde o mais eficiente, funcional e otimizada possível.

Quando devidamente detalhado e planeado, o PF é, a montante, a base de qualquer bom projeto e intervenção que se pretenda realizar, com vista ao correto funcionamento da unidade hospitalar e à manutenção da atualidade da intervenção, reduzindo ao máximo a sua obsolescência ou inadequação futura.

Espera-se que as recomendações propostas neste documento possam contribuir para uma maior eficácia e celeridade no processo de elaboração de um Programa Funcional, uma minimização das dúvidas, eliminação de erros de projeto, e ainda para a integração deste documento no processo de planeamento estratégico das intervenções em unidades de saúde, de uma forma eficaz, conjuntamente com os Planos Diretores de Unidades Hospitalares (PDUH) e o Perfil Assistencial que, em conjunto com o Programa Funcional, são documentos essenciais para o planeamento estratégico e desenvolvimento futuro das unidades hospitalares.

Definições

Antecâmara

Espaço de transição e barreira entre duas áreas com diferentes características.

Antecâmara SAS

Espaço de transição e barreira entre duas áreas com diferentes características de pressão e/ou assepsia. (SAS - *Special Airlock System*).

Ampliação

Intervenção realizada numa edificação existente de que resulte o aumento de qualquer dos seguintes parâmetros de edificabilidade: área de implantação; área bruta de construção; cércea ou altura total de construção; número de pisos, acima ou abaixo da cota de soleira.

Área bruta de construção

Valor expresso em m², resultante do somatório das superfícies de todos os pisos, acima e abaixo do solo, medidas pelo extradorso das paredes exteriores, incluindo escadas, caixas de elevadores e pisos técnicos, mas excluindo sótãos não utilizáveis e estacionamentos cobertos.

Área bruta de construção de estacionamento parcial ou totalmente subterrâneo

Valor expresso em m², resultante do somatório das áreas de todos os pisos de estacionamento acima ou abaixo do solo em edifício próprio ou integrado em edifício com outra funcionalidade, medidas pelo extradorso das paredes exteriores, incluindo escadas, rampas, caixas de elevadores e pisos técnicos.

Área de implantação

Valor expresso em m², correspondente ao somatório das áreas resultantes da projeção ortogonal no plano horizontal de todos os edifícios, incluindo anexos, mas excluindo varandas quando descobertas e palas.

Área do terreno

Valor expresso em m², correspondente à área da totalidade do terreno afeto à construção, medida pelo seu perímetro exterior.

Área Funcional

Agrupamento de espaços funcionais com características semelhantes ou funcionalmente interligados pela interdependência das atividades aí desenvolvidas. As áreas funcionais de uma unidade hospitalar podem variar consoante as valências e grau de diferenciação da própria unidade hospitalar e a respetiva agregação depende também dos procedimentos em uso na unidade ou tipologia de funcionamento preconizada.

Área impermeabilizada

Valor expresso em m², resultante do somatório das áreas ocupadas por edifícios, vias, passeios, estacionamentos, lagos e demais obras que impeçam a absorção de água pelo solo.

Área útil de programa (Aug)

Área útil de programa é a soma das áreas úteis de todos os compartimentos constantes do programa funcional

Área útil de projeto (Auj)

Área útil de projeto é a soma das áreas úteis de todos os compartimentos constantes do projeto

Cluster

Agrupamento de compartimentos de um mesmo serviço (consulta externa) que pelas suas características criam sinergias e partilham recursos comuns entre si, favorecendo a prestação de serviços de saúde aos utentes.

Edifícios de apoio e técnicos

Edifícios cuja ocupação predominante é de apoio aos serviços hospitalares, nomeadamente centrais técnicas, serviços de hotelaria e armazéns.

Edifício hospitalar

Edifício no qual são prestados serviços de cuidados de saúde diferenciados;

Equipa de projeto (EQP)

Equipa multidisciplinar constituída por técnicos, com as qualificações adequadas, da entidade adjudicante ou por ela contratados, abrangendo todas as especialidades constantes do projeto em causa, coordenada por um elemento para o efeito designado.

Equipa de revisão (EQR)

Equipa multidisciplinar constituída por técnicos, com as qualificações adequadas, da entidade adjudicante ou por ela contratados, abrangendo as mesmas especialidades representadas na EQP, coordenada por um elemento para o efeito designado.

Espaço Funcional

Espaço contido, onde se desenvolvem atividades de prestação de cuidados de saúde ou de apoio à prestação de cuidados de saúde, que se organiza em diversas áreas com características próprias (área de Entrada, Área Assistencial/técnica, Área de Apoios, Área de Pessoal e Área de familiares/visitas, quando aplicável).

Espaços exteriores

Designa o conjunto de áreas e “sistemas” (vegetais, infraestruturais, redes, etc) não edificadas dentro da cerca/recinto hospitalar. No âmbito dos espaços exteriores englobam-se todas as zonas circundantes do(s) edifício(s) hospitalares delimitados por uma vedação ou outro elemento arquitetónico.

Estacionamento à superfície

Parqueamento automóvel descoberto ou com cobertura leve, não integrado em qualquer tipo de edificação.

Estacionamento em edifício

Parqueamento automóvel incluído em espaço edificado, quer seja em silo ou em parte do edifício hospitalar.

Índice de Construção

Multiplicador urbanístico correspondente ao quociente entre o somatório das áreas de construção e a superfície de referência onde se pretende aplicar de forma homogénea o índice. A superfície de referência é neste caso a área do terreno.

O mesmo que Coeficiente de Ocupação do Solo (COS).

Índice de impermeabilização

Multiplicador urbanístico correspondente ao cociente entre a área impermeabilizada e a superfície de referência onde se pretende aplicar de forma homogénea o índice (Fonte: DGOTDU)

Instrumentos de planeamento territorial

Instrumentos que estabelecem o regime de uso do solo, definindo modelos de evolução da ocupação humana e da organização de redes e sistemas urbanos e, na escala adequada, parâmetros de aproveitamento do solo.

Lotação

Número total de camas que o hospital dispõe, com exclusão de:

- Berços, Camas de internamentos especiais (Unidade de Cuidados Intensivos, Unidade de cuidados intermédios, Unidade de Queimados, Unidade de infetocontagiosos)
- Camas da Urgência
- Camas de recobros

Mapeamento funcional

Identificação das funções associadas a cada espaço ou serviço.

Obscurecimento

Considera-se obscurecimento a ação de impedir a entrada de luz através de um vão.

Pé direito útil

É a altura livre entre o piso e o teto ou o teto falso.

Plano Diretor de Unidades Hospitalares (PDUH)

Documento que condensa todos os elementos escritos e gráficos de síntese que caracterizam o hospital e que define as linhas do respetivo desenvolvimento futuro.

Programa funcional (PF)

Documento que descreve o edifício detalhadamente, permitindo visualizar uma estrutura organizada para cada uma das especialidades envolvidas

Quarto de isolamento

Quarto de internamento com capacidade para um utente. Poderá ser utilizado para um utente com necessidades especiais de recolhimento (situações terminais; situações de grande agitação;)

Quarto de isolamento de contenção

Quarto de internamento com capacidade para um utente, com antecâmara e I.S. e com controlo de pressão negativa.

Quarto de isolamento de proteção

Quarto de internamento com capacidade para um utente, com antecâmara e I.S. e com controlo de pressão positiva.

Reabilitação

Intervenção que tem por fim a recuperação e beneficiação de um edifício, resolvendo as anomalias construtivas, funcionais, higiénicas e de segurança acumuladas ao longo dos anos, procedendo a uma modernização que melhore o seu desempenho até próximo dos atuais níveis de exigência.

Remodelação

Intervenção que tem por fim a alteração funcional de um edifício ou de parte dele, sem alterar as suas características estruturais.

Sombreamento

Em relação aos vãos exteriores ou interiores, considera-se por sombreamento a ação de impedir a insolação direta da superfície exterior do vão.

Zona de proteção

Área envolvente ao perímetro do empreendimento hospitalar, dentro da qual as intervenções urbanísticas são condicionadas.

Siglas

AF– Área Funcional

EF– Espaço Funcional

EH– Edifício Hospitalar

UH- Unidade Hospitalar

IS– Instalação Sanitária

MFR– Medicina Física e de Reabilitação

PF – Programa Funcional

PDUH–Plano Diretor de Unidade Hospitalar

PMC– Pessoas de mobilidade condicionada

ULS- Unidade Local de Saúde

URDMUM–Unidade de reprocessamento de dispositivos médicos de uso múltiplo

1. OBJETIVO

É objetivo do presente documento ser um guia facilitador no processo de elaboração de um programa funcional, com vista à elaboração de um projeto, para uma unidade hospitalar nova ou uma existente.

Sendo um hospital uma entidade orgânica, o programa funcional deve ter em conta todas as capacidades e complexidades técnicas, tecnológicas e funcionais do edifício, antecipando e precavendo as condicionantes futuras, permitindo que o edificado não fique obsoleto ou sem capacidade de crescimento e de alteração de uso a curto ou médio prazo.

Este documento pretende esclarecer os principais pontos que devem ser abordados, transversais a todos os programas funcionais, aos quais devem ser acrescentados outros, considerados importantes, em função das condições particulares de cada intervenção a realizar ou do tipo de hospital.

O programa funcional (PF) é parte integrante do Programa Preliminar que é definido na Alínea s) do Artº 1º do Anexo I da Portaria n.º 255/2023, de 7 de agosto: “s) «Programa preliminar», o documento fornecido pelo Dono da Obra ao Projectista para definição dos objectivos, características orgânicas e funcionais e condicionamentos financeiros da obra, bem como dos respectivos custos e prazos de execução a observar; corresponde ao programa preliminar previsto no artigo 43.º do CCP.”

Elaborado sob responsabilidade da unidade hospitalar/ Unidade Local de Saúde (e aprovado superiormente), o PF descreverá detalhadamente o edifício novo a construir ou existente a intervencionar, permitindo visualizar uma estrutura organizada para cada uma das especialidades envolvidas.

Este guia aborda também questões relativas à organização do documento, pretendendo tornar o documento mais claro e comparável para quem analisa e verifica e mais operacional para o projetista, facultando um entendimento mais expedito da organização funcional que se pretende para a intervenção em causa.

É igualmente abordada a questão da desejável uniformização das áreas de alguns dos compartimentos mais comuns e transversais a todas as unidades hospitalares, sejam elas unidades hospitalares mais diferenciadas ou de menor dimensão.

A uniformização de áreas pretende definir a área considerada ideal para o compartimento em causa, sem comprometer a sua funcionalidade atual e futura, absorvendo alguma da desejável flexibilidade que se pretende que exista mas sem gerar sobredimensionamento dos compartimentos com os consequentes custos associados, promovendo uma melhor gestão do erário público.

No presente documento, não é possível, pela extensão do processo, esclarecer todas as áreas de todos os compartimentos de uma unidade hospitalar, até porque muitas têm especificidades técnicas variáveis, e algumas unidades hospitalares têm diferentes graus de diferenciação e exigências mais complexas que devem ser planeadas e definidas em sede de elaboração do PF, pela equipa alocada à elaboração do mesmo em conjunto com os profissionais de saúde da própria unidade e pelo respetivo conselho diretivo.

No entanto, é sugerida uma aproximação a princípios básicos de dimensionamento que se considera uma ferramenta operativa que pode ser importante.

2. ESTRUTURA DO PROGRAMA FUNCIONAL

A organização da unidade de saúde deverá ser caracterizada em PF, referindo-se o tipo de modelo da unidade, a composição e objetivos de cada área funcional e de cada espaço funcional, bem como as respetivas relações e principais circuitos (utentes, visitas, pessoal e sujos/limpos), as portarias e entradas a considerar e todas as informações relevantes que contribuem para a clarificação do desenho da unidade.

O presente guia considera os seguintes pontos como essenciais para a abordagem de qualquer intervenção:

- Resumo da área de influência e do perfil assistencial da ULS/ unidade hospitalar
- Dimensionamento básico da unidade hospitalar / espaço funcional (requisitos mínimos de capacidade)
- Princípios orientadores (princípios estratégicos para o desenvolvimento do projeto e consequentemente da unidade hospitalar/espaço funcional)

- Organização da unidade hospitalar (áreas funcionais e espaços funcionais) e do espaço funcional (compartimentos)
- Plano geral de áreas
- Organização funcional e relações de proximidade (incluindo matriz de proximidades e, se relevante, indicações relativas a circulações, fluxos ou limitações de acesso)

Esta descrição será estruturada de acordo com a organização pretendida para a unidade hospitalar e desagregada da seguinte forma:

- **Áreas funcionais (AF)** – grandes áreas que integram espaços funcionais com valências compatíveis ou complementares. (ex. cirurgia, ambulatório, saúde mental, materno-infantil, oncologia, etc.)
- **Espaços funcionais (EF)** – muitas vezes apelidados de *serviços* ou *unidade*, são áreas contidas que podem ser encerradas e que agregam compartimentos pertencentes ao mesmo espaço funcional complementares entre si.
- **Compartimentos** – áreas que pertencem a um espaço funcional e que devem ser caracterizados pela:
 - função
 - Indicação das respetivas quantidades
 - Indicação das áreas (úteis) a considerarIndicações relevantes relativas a:
 - Proximidades
 - Relações com outros espaços funcionais
 - Instalações especiais
 - Circulações, fluxos ou limitações de acesso
 - Outras que sejam importantes para o correto desenvolvimento do projeto

3. ENQUADRAMENTO DA INTERVENÇÃO NA ULS

Neste capítulo, deve ser feita uma abordagem da intervenção em causa, contextualizando-a no conjunto da unidade local de saúde e da localização das várias valências na unidade local de saúde, podendo ser feita uma ligação ao PDUH, caso exista. Pretende-se que seja feito um enquadramento da intervenção em causa num contexto mais macro.

4. ENQUADRAMENTO DA INTERVENÇÃO NA UNIDADE HOSPITALAR

Neste capítulo, deve ser realizada uma abordagem da intervenção que se pretende, contextualizando-a na unidade hospitalar, esclarecendo esquematicamente os acessos exteriores existentes, os acessos verticais e as principais ligações logísticas que se devem assegurar, de forma a ter a perceção da sua localização no edifício existente e das suas eventuais condicionantes, quando se trate de uma intervenção numa unidade existente.

Em caso de edifício novo, localizado num complexo hospitalar, deve ser esclarecido o tipo de ligações que devem ser asseguradas aos restantes edifícios, identificação das áreas libertadas nos restantes edifícios pela intervenção em causa e relocalização das mesmas, assim como os acessos viários e alterações aos mesmos decorrentes da intervenção em causa.

Quer se trate de uma intervenção pontual num edifício existente, quer se trate de um edifício novo, deve ser acautelado que o faseamento da intervenção está definido e permite a manutenção do normal funcionamento dos restantes serviços hospitalares com o mínimo de constrangimentos para os utentes e profissionais, mantendo a operacionalidade da unidade hospitalar.

5. ÁREA DE INFLUÊNCIA E PERFIL ASSISTENCIAL

5.1. ÁREA DE INFLUÊNCIA

O Sistema de Livre Acesso e Circulação de Utentes no SNS (LAC) aprovado pelo Despacho n.º 5911-B/2016, de 3 de maio, permite aos utentes, em conjunto com o médico de família responsável pela referênciação, optar por qualquer uma das unidades hospitalares do SNS onde exista a consulta da especialidade que necessita. No seguimento do princípio referido, a unidade deverá atender a todos os utentes que a ela recorram independentemente da sua área de residência. Não obstante, para efeitos exclusivamente de planeamento, deve considerar-se o conceito de área de influência, que tem subjacente implicitamente que, em igualdade de circunstâncias, os utentes tendem a procurar resposta no local mais próximo para si.

Importa, por isso, referir no PF a estimativa da área de influência da unidade a ser planeada, tanto uma área de influência de 1ª linha, de 2ª linha ou de 3ª linha, caso se aplique.

5.2. PERFIL ASSISTENCIAL

O perfil assistencial é um documento de planeamento, efetuado a montante do PF e que é constituído por uma descrição de todas as áreas de atividade e das valências e especialidades que serão disponibilizadas pela unidade hospitalar.

Neste capítulo, deve ser realizado um resumo do perfil assistencial, o que pode ser obtido através de um quadro como o que a seguir se exemplifica:

Áreas	Especialidades
Médicas	Cardiologia
	Cardiologia Pediátrica
	Doenças Infecciosas
	Endocrinologia e Nutrição
	Gastroenterologia
	Genética Médica
	Hematologia Clínica
	Imunoalergologia
	Medicina do Trabalho
	Medicina Interna
	Nefrologia
	Neurologia
	Oncologia Médica
	Pediatria
	Pneumologia
	Psiquiatria
	Psiquiatria da Infância e da Adolescência
	Reumatologia

Áreas	Especialidades
Cirúrgicas	Angiologia e Cirurgia Vascular
	Cirurgia Cardíaca
	Cirurgia Geral
	Cirurgia Maxilo-Facial
	Cirurgia Pediátrica
	Cirurgia Plástica Reconstructiva e Estética
	Cirurgia Torácica
	Dermato-venereologia
	Estomatologia
	Ginecologia/Obstetrícia
	Neurocirurgia
	Oftalmologia
	Ortopedia
	Otorrinolaringologia
	Urologia
Diagnóstico e Terapêutica	Anatomia Patológica
	Anestesiologia
	Farmacologia Clínica
	Imunohemoterapia
	Medicina Física e de Reabilitação
	Medicina Nuclear
	Neurorradiologia
	Patologia Clínica
	Radiologia
	Radioncologia

6. REQUISITOS MÍNIMOS DE CAPACIDADE

O grupo de trabalho do Perfil Assistencial, Área de Influência e Dimensionamento deve definir os requisitos mínimos de capacidade para o Hospital.

Os requisitos mínimos de capacidade constituem-se como um elemento vinculativo e que servirão de base à elaboração do Programa Funcional e devem ser planeados por uma equipa multidisciplinar, envolvendo, se necessário, especialistas em áreas clínicas específicas. Esses requisitos mínimos de capacidade, ou dimensionamento básico da unidade hospitalar, serão sintetizados num quadro resumo como o que a seguir se exemplifica:

Requisitos Mínimos de Capacidade		
	Área de Atividade	Indicador de Capacidade
Internamento	Internamento Geral	Nº de camas
	Cuidados Intermédios Neonatais	Nº de boxes
	Cuidados Intensivos Neonatais	Nº de boxes
	Cuidados Intensivos Polivalentes	Nº de boxes
	Cuidados Intermédios	Nº de boxes
	Cuidados Intensivos Pediatria	Nº de boxes
	Cuidados Intermédios Pediatria	Nº de boxes
	Cuidados Especiais de Infecção contagiosos de Adultos	Nº de camas
	Cuidados Especiais Queimados	Nº de boxes
	Internamento de psiquiatria de adultos e da infância e Adolescência	Nº de camas
	Internamento de Medicina Física e de Reabilitação	Nº de camas
	Total: Internamento	
Salas de Operação	Cirurgia Programada Convencional	Nº de salas
	Cirurgia Urgente	Nº de salas
	Cirurgia de Ambulatório	Nº de salas
	Total: Salas de Operação	
Unidade de Cirurgia de Ambulatório	Sala de Recobro 1 (número de camas)	Nº de camas
	Sala de Recobro 2 (número de camas)	Nº de camas
	Sala de Recobro 3 (número de cadeirões)	Nº de cadeirões
Consultas Externas	Gabinetes de Consultas Externas	Nº de gabinetes
Bloco de Partos	Quartos de Parto	Nº de quartos
Hospital de Dia	Postos de quimioterapia e outras terapias afins	Nº de postos
	Aceleradores lineares (radioterapia)	Nº aceleradores
	Número de lugares de hospital de dia psiquiatria. e pedopsiquiatria	Nº de lugares
	Monitores de hemodiálise	Nº de monitores
	Número de postos de outro hospital de dia	Nº de postos

7. PRINCÍPIOS ORIENTADORES

Devem ser considerados, neste capítulo, os princípios estratégicos que devem orientar o desenvolvimento do projeto da unidade hospitalar, as recomendações de boas práticas, de forma a planear uma intervenção que responda às necessidades atuais e às perspetivas futuras de incremento da atividade assistencial e de desenvolvimento tecnológico e aos condicionamentos inerentes a uma intervenção num edifício existente, se aplicável.

No mínimo, devem ser tidos em conta os tópicos identificados seguidamente, independentemente de serem desenvolvidos outros que possam ser considerados relevantes de acordo com o tipo de intervenção ou o tipo de unidade hospitalar:

- Orientação para o utente
- Centralização e partilha dos recursos
- Flexibilidade e expansão futura
- Externalização de serviços não clínicos
- Sustentabilidade
- Inovação tecnológica
- Diferenciação de circuitos
- Entradas e saídas na unidade hospitalar
- Segurança dos utentes e profissionais
- Elevados níveis de fiabilidade e disponibilidade
- Humanização do ambiente hospitalar
- Partilha de recursos entre as atividades de ensino e investigação e as atividades de carácter assistencial
- Garantir a integração do hospital na rede de cuidados de saúde como charneira entre os cuidados primários e os cuidados continuados

7.1. ORIENTAÇÃO PARA O UTENTE

Qualquer intervenção, nova ou em edifício existente, deve promover a orientação para o utente, permitindo que a organização dos espaços se estruture por processos e/ou áreas de gestão clínica, elementos que os novos paradigmas de transformação organizacional, digital e cultural vieram impor. Esta organização por processos permitirá uma maior flexibilidade organizacional, incorporando no seu modo de funcionamento as melhores práticas a nível mundial, fomentando o trabalho de equipa criando áreas clínicas ou áreas funcionais com capacidade técnica e funcional de prestação de cuidados em regime de internamento e de ambulatório.

Devem ser considerados os seguintes objetivos:

- Organização e agrupamento dos espaços funcionais;
- Incentivo do trabalho em equipa;
- Criação e evolução de Áreas Funcionais, integrando várias especialidades.

7.2. CENTRALIZAÇÃO E PARTILHA DE RECURSOS

Neste ponto, devem ser descritas as opções integradas no PF que visam fomentar a centralização e partilha de recursos, tanto administrativos como de carácter técnico-assistencial, promovendo o trabalho em equipa e permitindo um maior controlo da qualidade e dos resultados, nomeadamente incentivando as seguintes opções:

- Fomento de uma melhor centralização e partilha de recursos administrativos e de carácter técnico-assistencial, promovendo a existência de salas operatórias polivalentes, internamentos polivalentes e partilhados pelas várias especialidades médicas e cirúrgicas (com exceção dos internamentos de pediatria

e obstetria), radiologia que permita uma proximidade e utilização pela urgência, organização das consultas por “clusters”, entre outros.

- Em unidades de maior dimensão e como forma de preparar a evolução futura, poderá ser considerada a integração de sistemas robotizados de transporte para potenciar um modelo de gestão de fornecimentos, dimensionando e preparando as comunicações verticais e horizontais para essa tecnologia, prevendo no PF quais os EF que beneficiarão desse transporte robotizado de forma a conceber átrios de descarga junto dos acessos ao espaço funcional.

7.3. FLEXIBILIDADE E EXPANSÃO FUTURA

Neste ponto, devem ser descritas as principais linhas orientadoras em termos de flexibilidade e expansão futura e opções a assegurar que visem a adequação futura da intervenção:

- Promover um elevado grau de flexibilidade na utilização dos espaços;
- Prever a adaptação futura às mudanças constantes no modelo de cuidados;
- Prever espaços de reserva em áreas estratégicas, para resposta a aumentos da procura (exemplos: consulta externa/exames especiais, hospitais de dia, cirurgia de ambulatório, oncologia, saúde mental)
- Dar especial atenção a serviços em evolução tecnológica acentuada, como os blocos operatórios, acautelando que o planeamento atual não compromete a existência futura de salas operatórias híbridas, de acordo com o perfil assistencial e dimensão da unidade hospitalar.
- Projetar áreas com alta tecnologia – áreas funcionais com instalações pesadas, proteções antirradiações, climatização diferenciada, gaiola de Faraday - com reserva prévia de espaços, devendo o PF indicar quais as áreas funcionais onde devem ser previstas áreas de reserva.
- Identificar áreas de potencial crescimento para fora dos limites construídos que, sem comprometer as interligações funcionais, permitam uma expansão futura, quer em altura quer para fora do perímetro construído.

7.4. EXTERNALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CLÍNICOS

Neste ponto, devem ser descritos quais os serviços não clínicos que serão externalizados, libertando a unidade de saúde para o foco na prestação de cuidados médicos:

- O PF deve definir os espaços funcionais para os quais se prevê a externalização de serviços não clínicos, deixando à gestão do hospital a opção de externalizar estes serviços. Esta externalização de serviços não clínicos é cada vez mais uma realidade, libertando da área hospitalar serviços para os quais outros podem dar resposta.
- As seguintes áreas têm vindo a ser externalizadas:
 - Segurança
 - Alimentação
 - Limpeza
 - Manutenção
 - Tratamento de roupa
 - Gestão de resíduos
 - Reprocessamento de dispositivos médicos de uso múltiplo
 - Gestão de estacionamento
 - Lojas

Este planeamento prévio de áreas a externalizar permitirá que, em fase de projeto, se possa autonomizar funcionalmente estas áreas. Isto evitará, na operação diária, que fornecedores e profissionais externos à

unidade hospitalar devassem os circuitos internos da unidade hospitalar, com incremento da eficácia e da segurança, assim como promover uma desagregação de custos mais eficaz.

7.5. SUSTENTABILIDADE

Qualquer intervenção a realizar, seja construção nova ou reabilitação, deve minimizar o impacte ambiental da unidade hospitalar durante o seu ciclo de vida, ou seja, desde a conceção, construção, utilização, até ao fim de vida, promovendo a sustentabilidade ambiental desde a elaboração do respetivo PF. Essa redução do impacte ambiental e minimização da pegada de carbono poderá ser conseguida através de:

- Incorporação de soluções e materiais sustentáveis na construção, compatíveis com a assepsia que se pretende numa unidade hospitalar;
- Utilização de fontes renováveis de energia para autoconsumo;
- Racionalização dos consumos durante a exploração, procurando que o edifício seja autossustentável em termos de produção e consumo de recursos;
- Minimização da poluição sonora;
- Adequação do tratamento dos lixos e dos resíduos;
- Fomentar a utilização de processos digitais;
- Incorporação de postos de carregamento de carros elétricos no estacionamento e incorporação de estacionamento de bicicletas promovendo o seu uso por parte de utentes e profissionais;
- Assegurar, em articulação com os municípios, os adequados acessos de transportes públicos coletivos às unidades, assim como ciclovias;
- Promover o armazenamento das águas pluviais para rega de espaços exteriores e combate a incêndios;
- Promover uma adequada orientação solar do edifício hospitalar e dos quartos de internamento e uma utilização de sistemas de sombreamento adequados aos vários quadrantes solares;
- Adequação do dimensionamento dos vãos exteriores ao quadrante para o qual estão orientados;
- Promoção da integração de espaços verdes na envolvente e redução de áreas impermeabilizadas.

7.6. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

O PF deve prever e incorporar a evolução da tecnologia em todas as atividades assistenciais e administrativas, garantindo a sua integração futura através de:

- Capacidade de acolher adequadamente um contingente tecnológico muito pesado e, através da utilização de materiais e disposição dos espaços, permitir uma eficaz reposição tecnológica, ou seja, prever circuitos dimensionados e planeados para eventual substituição de equipamentos pesados;
- Transmitir aos utentes e profissionais uma imagem de modernidade, sofisticação e segurança;
- Promoção de um hospital sem papel, garantindo que os espaços contemplam esta condição, não apenas no âmbito das instalações de engenharia, mas também no projeto de arquitetura, de forma a permitir o uso constante, completo e universal dos meios informáticos por parte de todos os utentes do hospital;
- Integração de tecnologias avançadas de comunicações;
- Incorporação de postos de trabalho móveis;

- Integração de recursos para telemedicina;
- Integração de recursos para teleformação;
- Incorporação de meios de transporte robotizados para transporte de roupas e material logístico e de transporte pneumático de amostras para os laboratórios.

Assim, em termos de compartimentação, o PF deve prever:

- Espaços próprios de suporte ao processo de informatização;
- Um conjunto de espaços (áreas e instalações) para realização das atividades assistenciais sem documentação em suporte físico.

7.7. DIFERENCIAÇÃO DE CIRCUITOS

De forma a promover a segurança e conforto de utentes e profissionais e a eficácia das deslocações e transportes, a unidade hospitalar deve contemplar a adequada diferenciação e separação entre circuitos técnicos e de utentes na unidade hospitalar:

- Uteses internos (entre estes, sempre que possível deve diferenciar-se o circuito para utentes pediátricos);
- Uteses ambulatoriais;
- Profissionais;
- Abastecimentos;
- Saída de sujos;
- Visitas.

Sempre que possível e que a natureza do serviço o aconselhe, devem ser acautelados circuitos para utentes pediátricos com esperas próprias, de forma a minimizar cruzamentos com utentes adultos. Nos espaços funcionais em que não se justifiquem espaços exclusivamente pediátricos e sempre que os mesmos sejam utilizados por utentes pediátricos, deve-se prever compartimentos com ambiente pediátrico, nomeadamente:

- Salas de espera;
- Instalações sanitárias infantis;
- Áreas de jogos.

Numa unidade hospitalar, mais do que em qualquer outra tipologia de edifício, deve existir um cuidado ainda maior relativo ao design universal, acautelando a acessibilidade e circulação de pessoas com restrições de mobilidade (cadeiras de rodas, acamados), indo mais além das normas técnicas de promoção da acessibilidade consagradas no DL 163/2006 de 8 de agosto. Alguns aspetos que devem ser acautelados são:

- Os espaços funcionais devem ter locais de espera para utentes acamados;
- Os gabinetes das consultas externas devem ter de garantir o acesso e permanência de um utente em maca.

7.8. ENTRADAS/SAÍDAS DA UNIDADE HOSPITALAR

As entradas/saídas na unidade hospitalar devem estar definidas no PF, assegurando acessos diferenciados às diversas áreas funcionais, promovendo um acesso mais direto a utentes ambulatoriais, garantido o necessário controlo de entradas/saídas e da natureza dos fluxos (pessoas e materiais), evitando cruzamentos indesejáveis entre fluxos de utentes internos e utentes ambulatoriais.

O número de entradas e portarias deverá ser limitado, sem que, no entanto, se verifiquem estrangulamentos ou cruzamentos indesejáveis nos acessos.

Dependendo da dimensão da unidade a planear, além da entrada principal e entrada de urgências, podem ser consideradas algumas entradas próprias em alguns espaços funcionais que, com esta medida, beneficiam da autonomia de entradas/saídas gerando uma melhor gestão de fluxos de utentes:

- Medicina Física e de Reabilitação;
- Hospitais de dia;
- Consultas Externas;
- Oncologia;
- Saúde mental;
- Hemodiálise.

Em termos de entradas de logística, estas devem realizar-se através de cais de cargas/descargas, resguardadas de circuitos de utentes. Dependendo da dimensão da unidade a planear, podem ser consideradas as seguintes entradas/saídas de abastecimentos e material:

- Armazéns;
- Lavandaria e tratamento de roupa;
- Cozinha;
- Centrais técnicas;
- Farmácia;
- Ecocentro hospitalar;
- Casa mortuária.

As entradas no edifício hospitalar a partir do estacionamento subterrâneo devem ser controláveis a partir da admissão. Não deve ser permitido que os elevadores do estacionamento deem acesso indevido aos restantes pisos da unidade.

7.9. SEGURANÇA DOS UTENTES E PROFISSIONAIS

A segurança de utentes e profissionais é um desígnio básico de uma unidade hospitalar e essa segurança deve ser garantida através do cumprimento da legislação específica de segurança contra incêndios, segurança em caso de sismos, radiações ionizantes, resíduos perigosos, descargas atmosféricas e intrusão, de acordo com a legislação em vigor em cada momento.

Adicionalmente, existem outros parâmetros de segurança que muitas vezes se traduzem em desafios difíceis de transpor, pelo que deve ser acautelado que:

- Idealmente, os gabinetes e salas de prestação de cuidados dos serviços de urgência devem possuir porta de fuga para os profissionais, bem como estar equipados com dispositivos de segurança, como botão de alarme, para acionar o posto de segurança da unidade. Estes princípios devem também ser previstos na consulta externa, se possível.
- Deve ser previsto sistema de controlo de acessos a áreas mais reservadas do hospital, designadamente, salas cirúrgicas, bloco de partos e unidades de cuidados intensivos.
- Devem ser previstos sistemas eletrónicos que evitem o risco de rapto de crianças e troca de recém-nascidos.
- As escadas de emergência não devem dar acesso indevido ao interior de um espaço funcional, devendo estes sempre ser acessíveis a partir de circulações gerais da unidade hospitalar.
- Não permitir que os elevadores provenientes do estacionamento deem acesso a todos os pisos do hospital. Estes equipamentos devem dar acesso unicamente ao piso das entradas/admissões, numa área controlável por portaria, a partir da qual se encaminham os utentes para outras áreas ou elevadores.

- As vias exteriores de entrada/ saída de viaturas de emergência não devem cruzar zonas pedonais e de acesso de utentes a outras áreas funcionais.
- Evitar que os gabinetes de consulta confinem diretamente com as zonas de esperas, evitando que os utentes possam interromper consultas de outros utentes ou interpelar os profissionais.
- Promover cuidados específicos nas áreas de saúde mental, localizando os internamentos em piso térreo ou outro piso desde que permita acesso a áreas exteriores controladas e protegidas. Nesta área funcional, deve ser acautelada a fixação de equipamentos, a escolha de equipamentos sanitários e a limitação de abertura e fecho de vãos interiores e exteriores.

7.10. ELEVADOS NÍVEIS DE DISPONIBILIDADE E FIABILIDADE

Os processos assistenciais que se desenvolvem nos hospitais caracterizam-se pelo desenvolvimento do princípio de confiança: confiança dos utentes nos profissionais, dos profissionais entre si, e de todos eles na tecnologia que lhes dá apoio. O edifício deve por isso ser um espaço fiável e que transmita confiança, com elevados níveis de disponibilidade das diversas componentes. Entre outros aspetos que o tornam fiável e que geram uma perceção de fiabilidade e segurança, podem ser referidos os seguintes aspetos:

- Os espaços do hospital, os materiais utilizados, devem transmitir segurança pela perceção da qualidade e da manutenção dos mesmos.
- A sinalética deve ser facilmente entendível para uma fácil orientação dos utentes.
- A disposição espacial de mobiliário móvel deve promover circulações fluídas.

7.11. HUMANIZAÇÃO DO AMBIENTE HOSPITALAR

A arquitetura deve ser capaz de transmitir uma imagem de conforto e sensibilidade humana e devem ser implementadas medidas arquitetónicas que contribuam para uma maior humanização dos espaços, nomeadamente através de:

- O PF deve promover elevados níveis de habitabilidade e conforto a todos os utilizadores da unidade hospitalar (utentes e acompanhantes, visitas, profissionais), incentivando a utilização de luz natural direta em todos os espaços com permanência previsível de pessoas, sempre que possível (incluindo quartos de internamento, quartos de isolamento, postos de cuidados intensivos e intermédios, postos de hospital de dia, gabinetes de consulta, áreas de trabalho de enfermagem, áreas administrativas, salas de espera, entre outros), assim como ventilação natural.
- Integração no meio hospitalar, nas áreas onde há utentes pediátricos, de espaços percecionados como “menos” medicalizados e de espaços lúdicos.
- O PF deve contribuir para apaziguar o sofrimento intrínseco à pessoa doente e familiares, prevendo espaços físicos confortáveis, seguros e humanizados que proporcionem ao utente e aos seus acompanhantes uma integridade física e afetiva.
- Existência de áreas que favoreçam os cuidados personalizados e promovam a privacidade dos utentes.
- Prever o acompanhamento do utente por um familiar, assegurando a existência de espaços para o efeito, nomeadamente na obstetrícia e pediatria. (vestiários para pais, cadeirão reclinável nos quartos de pediatria, etc)

7.12. PARTILHA DE RECURSOS ENTRE AS ATIVIDADES DE ENSINO E ENTRE AS ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL

Dependendo da dimensão e diferenciação da unidade hospitalar, esta deve acolher atividades de ensino e de investigação, que beneficiem da proximidade das atividades assistenciais.

As atividades de ensino devem, sempre que possível, partilhar espaços e recursos técnicos, procurando a máxima integração nos espaços de apoio às atividades assistenciais, prevendo nas áreas assistenciais salas de trabalho e ensino, integrando atividades docentes e assistenciais, sem, no entanto, interferir no funcionamento das unidades.

Os espaços funcionais destinados à atividade de ensino devem ter uma utilização partilhada entre os utentes universitários ou de outras instituições de ensino e os profissionais do hospital para formação.

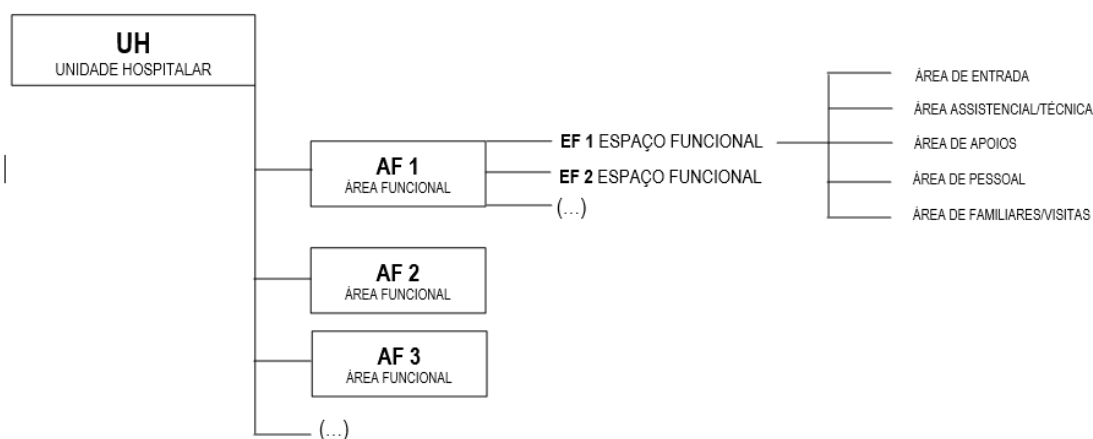
7.13. INTEGRAÇÃO DO HOSPITAL NA REDE DE CUIDADOS DE SAÚDE

A unidade hospitalar deve ser o elemento charneira na rede de cuidados de saúde, integrando-se com os cuidados primários e os cuidados continuados.

8. ORGANIZAÇÃO DO HOSPITAL: ÁREAS E ESPAÇOS FUNCIONAIS

Neste capítulo, devem ser apresentadas as principais características funcionais e requisitos de organização dos espaços a criar ou intervencionar.

A estrutura que deve ser considerada para uma organização mais eficaz e lógica do Programa Funcional, com reflexo na organização hospitalar, é traduzida no seguinte esquema:



Uma Área Funcional corresponde a um grande grupo de espaços funcionais com características semelhantes ou funcionalmente ligados pela interdependência das atividades aí desenvolvidas. As áreas funcionais de uma unidade hospitalar vão variar consoante as valências e grau de diferenciação da própria unidade hospitalar e a respetiva agregação depende também dos procedimentos em uso na unidade ou tipologia de funcionamento preconizada.

Como exemplos de Áreas Funcionais, que devem ser adaptadas a cada realidade hospitalar em particular, podem ser consideradas as seguintes:

8.1. ÁREAS FUNCIONAIS

8.1.1 AF MATERNO INFANTIL

Pode incluir os seguintes espaços funcionais (EF):

- EF Consultas externas e exames materno-infantil
- EF Hospital de dia pediátrico
- EF Procriação medicamente assistida
- EF Internamento pediátrico
- EF Internamento de ginecologia/obstetrícia
- EF Unidade de cuidados intensivos e intermédios neonatais e pediátricos
- EF Urgência pediátrica
- EF Urgência gineco-obstétrica/bloco de partos

8.1.2 AF AMBULATÓRIO

Pode incluir os seguintes espaços funcionais (EF):

- EF Consulta externa
- EF Exames especiais
- EF Hospitais de dia
- EF Hemodiálise
- EF Medicina Física e de Reabilitação
- EF Central de colheitas

8.1.3 AF CIRURGIA

Pode incluir os seguintes espaços funcionais (EF):

- EF Cirurgia convencional
- EF Cirurgia de ambulatório
- EF Recobro

8.1.4 AF INTERNAMENTO

Pode incluir os seguintes espaços funcionais (EF):

- EF Internamentos convencionais (step up/step down, médico, cirúrgico)
- EF Internamento de infetocontagiosos
- EF Internamento de transplante de medula
- EF Internamento com laboratório de sono

8.1.5 AF CUIDADOS INTENSIVOS E ESPECIAIS

Pode incluir os seguintes espaços funcionais (EF):

- EF Cuidados Intensivos (polivalentes, AVC's, coronários, etc)
- EF Cuidados intermédios
- EF Queimados

8.1.6 AF URGÊNCIA

Pode incluir os seguintes espaços funcionais (EF):

- EF Urgência Geral (e Pediátrica e Ginecologia e Obstetrícia, no caso de não existir uma AF materno-infantil)
- EF VMER

8.1.7 AF SAÚDE MENTAL

Pode incluir os seguintes espaços funcionais (EF):

- EF Consulta externa de saúde mental
- EF Hospital de dia de saúde mental
- EF Internamento de saúde mental

8.1.8 AF ONCOLOGIA

Pode incluir os seguintes espaços funcionais (EF):

- EF Hospital de dia de oncologia
- EF Radioncologia
- EF Medicina nuclear

8.1.9 AF CENTRO TECNOLÓGICO

Pode incluir os seguintes espaços funcionais (EF):

- EF Radiologia
- EF Hemodinâmica
- EF Radiologia de intervenção

8.1.10 AF BIOMÉDICAS

Pode incluir os seguintes espaços funcionais (EF):

- EF Laboratório de patologia clínica
- EF Laboratório de anatomia patológica
- EF Imunohemoterapia
- EF Coordenador de colheita e transplantação
- EF Banco de células e tecidos
- EF Banco de leite humano

8.1.11 AF FARMÁCIA

Pode incluir os seguintes espaços funcionais (EF):

- EF Farmácia hospitalar
- EF Posto avançado de farmácia

8.1.12 AF URDMUM (Unidade de reprocessamento de dispositivos médicos de uso múltiplo)**8.1.13 AF ÁREAS DE PESSOAL**

Pode incluir os seguintes espaços funcionais (EF):

- EF Restaurante de pessoal
- EF Cafeteria
- EF Vestiário central
- EF Saúde ocupacional

8.1.14 AF GESTÃO DE UTENTES

Pode incluir os seguintes espaços funcionais (EF):

- EF Entradas e portarias
- EF Gabinete do cidadão
- EF Admissão e gestão de utentes
- EF Arquivo clínico e codificação clínica
- EF Serviço religioso
- EF Cafetaria
- EF Apoio social, psicologia
- EF Áreas públicas

8.1.15 AF SERVIÇOS GERAIS

Pode incluir os seguintes espaços funcionais (EF):

- EF Cozinha
- EF Serviço de instalações e equipamentos
- EF Ecocentro hospitalar
- EF Estacionamento
- EF Armazém geral
- EF Lavandaria e tratamento de roupa
- EF Central de limpeza
- EF Central telefónica e de segurança
- EF Central de camas

8.1.16 AF ADMINISTRAÇÃO (pool administrativa, TI e telecomunicações, Direção e administração)

Pode incluir os seguintes espaços funcionais (EF):

- EF Pool administrativa
- EF TI e telecomunicações
- EF Direção e administração
- EF Entidade gestora do edifício (caso aplicável)

8.1.17 AF FORMAÇÃO E ENSINO

Pode incluir os seguintes espaços funcionais (EF):

- EF Salas e anfiteatros
- EF Espaço do aluno (caso aplicável)
- EF Biblioteca e videoteca

8.1.18 AF INVESTIGAÇÃO

Pode incluir os seguintes espaços funcionais (EF):

- EF Investigação (caso aplicável)

8.2. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FUNCIONAL (EF)

Cada uma das Áreas Funcionais (AF) sugeridas anteriormente são compostas por espaços funcionais (EF), que são espaços contidos com características próprias. Estes EF devem ser caracterizados o mais detalhadamente possível, referindo a sua **função**, uma abordagem à sua **organização**, requisitos de **capacidade**, **localização**, **relações de proximidade** e a **listagem de compartimentos** que o constitui, traduzida no Plano de Áreas. A sequencialidade do Plano de Áreas, abordado mais à frente, deve seguir uma organização de acordo com as seguintes cinco grandes áreas e com a ordem discriminada, de forma a melhor traduzir uma organização funcional coerente e mais facilmente perceptível:

- Área de Entrada
- Área Assistencial/técnica
- Área de Apoios
- Área de Pessoal
- Área de familiares/visitas

Todos os elementos referidos para caracterizar os espaços funcionais devem constar de capítulo próprio sobre esse espaço funcional e/ou constar no plano de áreas.

Função: a definição da função de cada Espaço Funcional é fundamental para caracterizar o tipo de prestação de cuidados de saúde a realizar, referindo se existem particularidades próprias, horário de funcionamento, tipos de acesso (acesso direto ao exterior, por exemplo), ou outros aspetos considerados relevantes.

Organização: deve ser referido o tipo de organização funcional que se pretende, se for preconizada uma organização específica por motivos justificados, como por exemplo se um bloco se deve organizar em corredor único ou duplo corredor de limpos e sujos, se um determinado espaço funcional precisa de um corredor específico de visitas como nos infetocontagiosos, se a unidade de cuidados intensivos se organiza em boxes ou área aberta, entre outros requisitos mais específicos.

Capacidade: os requisitos de capacidade devem ser definidos a montante da elaboração do PF, numa fase de planeamento anterior, aquando da elaboração do perfil assistencial e dimensionamento. A capacidade, no entanto, deve voltar a ser referida neste capítulo.

Localização: a indicação quanto à localização preferencial do EF dentro da estrutura global da unidade hospitalar permite um planeamento adequado dos circuitos de profissionais, materiais, utentes, minimizando percursos e tornando-os mais eficazes, assim como estabelecer relações de proximidade com espaços funcionais complementares. A referência à localização será fundamental no caso de espaços funcionais que precisam entrada direta do exterior para doentes, para abastecimentos ou saída de sujos. Também poderá ficar traduzida na matriz de proximidades, abordada mais à frente, onde serão especificadas proximidades do EF em relação a outros espaços funcionais, quando sejam relevantes.

Listagem de compartimentos: A listagem de compartimentos é traduzida no plano de áreas, que se aborda de seguida, e fornece a maior parte da informação necessária para a definição do espaço funcional, enumerando os compartimentos e agregando-os, especificando a quantidade, a área e referindo condicionantes caso existam, como por exemplo se um determinado compartimento não deve ter luz natural, ou se deve ter visualização direta sobre outro compartimento, ou se tem outra especificidade que deva ser referida.

9. PLANO DE ÁREAS

A listagem de compartimentos deverá organizar-se de acordo com a estrutura abaixo definida e serão indicadas as quantidades, as áreas úteis dos compartimentos, as áreas úteis globais (soma das áreas úteis dos vários compartimentos) para cada área funcional e para cada espaço funcional. As áreas de circulações não são contabilizadas no plano de áreas e devem cumprir o estipulado nas [Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar](#) da ACSS, IP.

O Plano de Áreas incluirá a referência a todos os compartimentos com a respetiva designação (nome e código, a inserir nas peças desenhadas), a área útil, a quantidade de compartimentos iguais e a área útil total.

Deve ser esclarecido que, quando as áreas de compartimentos se definem por “x” m² por cama/posto/cadeirão, essa área é unicamente afeta a essa cama/posto/cadeirão e não inclui as áreas de circulação necessárias à sua funcionalidade.

Para cada um dos compartimentos listados, referenciados pelo mesmo código e organizados de acordo com a mesma terminologia, será descrita a respetiva funcionalidade e referidas todas as características que possam influenciar o projeto.

Deve privilegiar-se a uniformização de áreas para compartimentos com a mesma função, promovendo uma maior flexibilidade dos espaços.

Este capítulo, que pode figurar como anexo, deve incluir a listagem exaustiva de todos os compartimentos e áreas úteis dos vários espaços funcionais, sob a forma de tabela que, apenas a título de exemplo, se caracteriza seguidamente:

INTERNAMENTO GERAL

ÁREA DE ENTRADA	m ²	unidade	total	função	
Quarto duplo (*)	20	6	120	Quarto com duas camas de internamento, onde permanecem dois utentes durante o seu internamento hospitalar	Áreas úteis
Instalação sanitária utentes	5	6	30	I.S. com duche para utilização pelo(s) utente(s) internados no quarto	
Quarto individual com capacidade de expansão (*)	20	9	180	Quarto para a permanência de um utente durante o seu internamento hospitalar, com uma cama de internamento, e permitindo um acompanhante	
Instalação sanitária utentes	5	9	45	I.S. com duche para utilização pelo(s) utente(s) internados no quarto	
Quarto individual (*)	20	8	160	Quarto para a permanência de um utente durante o seu internamento hospitalar, com uma cama de internamento, e permitindo um acompanhante	Quantidade
Instalação sanitária utentes	5	8	40	I.S. com duche para utilização pelo(s) utente(s) internados no quarto	
Quarto para utentes isolados (**)	15	2	30	Quarto de internamento para utentes com necessidades de isolamento com adufa na entrada e pressão negativa	
Instalação sanitária utentes	5	2	10	I.S. com duche para utilização pelo(s) utente(s) internados no quarto	
Adufa	5	2	10	Atuar como barreira para aceder ao sector estéril	
Sala de estar utentes internados (check-in/check-out)	30	1	30	Área de espera utentes/visitas	

10. ÁREAS DE COMPARTIMENTOS MAIS COMUNS

O presente capítulo não pretende impor e definir áreas de compartimentos, pretende apenas ter um caráter orientador, contribuindo para uma maior uniformização de áreas de compartimentos mais comuns e repetíveis numa unidade hospitalar.

A uniformização de áreas de compartimentos que têm a mesma função torna o plano de áreas mais operativo e comparável, evitando excesso de áreas em alguns compartimentos ou áreas subdimensionadas noutros. Esta abordagem quanto às áreas não pretende, nem deverá ser exaustiva.

Áreas de compartimentos cuja dimensão depende do número de utilizadores serão abordadas no seguinte capítulo.

COMPARTIMENTO TIPO	ÁREA ÚTIL (m²)	LARGURA (m)	OBSERVAÇÕES
GABINETE DE CONSULTA	16	2,6	
GABINETE DE CONSULTA DE OBSTETRÍCIA/GINECOLOGIA	16	2,6	
GABINETE DE TRABALHO MÉDICO / GABINETE DE ENFERMAGEM/ GABINETE DE TRABALHO/GABINETE DE INFORMAÇÃO	12		
GABINETE DE TRABALHO DE ENFERMAGEM	12		
SALA DE TRATAMENTOS	16	3,5	
SALA DE OPERAÇÕES	45-60	4,5	
SALA HÍBRIDA	120		
ZONA DE DESINFECÇÃO EM ÁREA ABERTA	4		Comum a duas salas de operações
SALA DE PEQUENA CIRURGIA	16	3,5	Com zona de desinfeção exterior, não incluída nesta área
SALA DE GESSOS	20		
QUARTO INDIVIDUAL	20		Os quartos devem ser tendencialmente individuais ou duplos, com a mesma área para fomentar a flexibilidade. Os quartos individuais devem ter capacidade de expansão para mais uma cama, em caso de contingência.
QUARTO DUPLO	20		Os quartos devem ser tendencialmente individuais ou duplos, com a mesma área para fomentar a flexibilidade. Os quartos individuais devem ter capacidade de expansão para mais uma cama, em caso de contingência.
QUARTO DE ISOLAMENTO COM ANTECÂMARA	15+5		
ANTECÂMARA	5		

Guia para elaboração de programas funcionais

BANHO ASSISTIDO	10		
QUARTO PARTO	25		
INSTALAÇÃO SANITÁRIA ACESSÍVEL (SEM DUCHE)	5		Para pessoas de mobilidade condicionada
INSTALAÇÃO SANITÁRIA ACESSÍVEL (COM DUCHE)	6		Quartos de internamento
INSTALAÇÃO SANITÁRIA DE PESSOAL COM ANTECÂMARA COM LAVATÓRIO	10		Módulo com antecâmara com lavatório e duas cabines de retrete com lavatório.
I.S. INFANTIL COM FRALDÁRIO	10		Módulo de I.S. com antecâmara com lavatório e fraldário e duas cabines de retrete
POSTO DE VIGILÂNCIA E TRABALHO DE ENFERMAGEM	20-28		Posto de controlo de enfermagem com balcão, em ligação à circulação (8/10 m ²) e retaguarda com duas zonas individualizadas, uma delas para registos (8/10m ²) e outra para preparação de medicação (4/ 8 m ²). Dimensão dependerá do nº de postos/ dimensão da unidade.
BOX/POSTO DE TRATAMENTO HOSPITAL DE DIA (ADULTO)	12		A área é por posto e não inclui posto de vigilância/trabalho de enfermagem nem circulação.
BOX/POSTO DE TRATAMENTO HOSPITAL DE DIA (PEDIÁTRICO)	10		A área é por box/posto e não inclui posto de vigilância/trabalho de enfermagem nem circulação.
BOX/ POSTO DE TRATAMENTO EM CAMA (CUIDADOS INTERMÉDIOS)	20		A área é por box/posto e não inclui posto de vigilância/trabalho de enfermagem nem circulação. A área por cama/box de cuidados intensivos e intermédios deve ser a mesma para fomentar a flexibilidade e ajustar às necessidades de expansão de cuidados intensivos em períodos de contingência.
BOX/ POSTO DE TRATAMENTO EM CAMA (CUIDADOS INTENSIVOS)	20		A área é por box/posto e não inclui posto de vigilância/trabalho de enfermagem nem circulação. A área por cama/box de cuidados intensivos e intermédios deve ser a mesma para fomentar a flexibilidade e ajustar às necessidades de expansão de cuidados intensivos em períodos de contingência.
BOX/POSTO EM UCPA	12		A área é por box/posto e não inclui posto de vigilância/trabalho de enfermagem nem circulação.
BOX/POSTO DE RECOBRO (CAMA)	10		A área é por box/posto e não inclui posto de vigilância/trabalho de enfermagem nem circulação.
BOX/POSTO DE RECOBRO (CADEIRÃO)	6		A área é por box/posto e não inclui posto de vigilância/trabalho de enfermagem nem circulação.
BOX/POSTO DE TRATAMENTO EM BERÇO (NEONATOLOGIA)	10		A área é por box/posto e não inclui posto de vigilância/trabalho de enfermagem nem circulação.
BOX/POSTO DE TRATAMENTO EM INCUBADORA (NEONATOLOGIA)	14		A área é por box/posto e não inclui posto de vigilância/trabalho de enfermagem nem circulação.
BOX/POSTO DE TRATAMENTO EM CAMA (INTERMÉDIOS/INTENSIVOS DE PEDIATRIA)	20		A área é por box/posto e não inclui posto de vigilância/trabalho de enfermagem nem circulação.
BOX/POSTO OBSERVAÇÃO URGÊNCIA	12		
SALA DE RX CONVENCIONAL	30		Não inclui vestiários nem sala de comando

SALA DE TAC	40		Não inclui vestiários nem sala de comando
SALA DE ECOGRAFIA	16		Não inclui I.S.
SALA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	60		
SALA DE COMANDO	8-12		A área dependerá do nº de salas. Admite-se que a área de 8 m ² é apenas para comando de uma sala de RX/TAC/Câmara-gama/ressonância magnética e 10 m ² para dois postos e 12 m ² para três postos.
SALA DE CÂMARA-GAMA	30		
SALA DE PET	100		Inclui área técnica
SALA CONTROLO PET	20		
VESTIÁRIO DE UTENTES ADJACENTE A SALA DE EXAMES	2		
VESTIÁRIO DE UTENTES COM MOBILIDADE CONDICIONADA ADJACENTE À SALA DE EXAMES	3		
PARQUE DE MACAS/ CADEIRAS DE RODAS	10-20		Dependente do tipo de espaço funcional
COPA	8-12		Copa maior em unidades de internamento
SALA DE SUJOS	6-9		Sala de sujos de 9m ² em EF onde há maior produção (UCI, intermédios, bloco, urgência, internamentos)
DEPÓSITO DE SACOS	9		Junto à entrada/saída do espaço funcional, preferencialmente com porta para o interior do espaço funcional e outra para o exterior do EF. evitando a devassa do serviço por pessoal externo para recolha.
RECEÇÃO/SECRETARIA	12		

11. CÁLCULO DE ÁREAS DE COMPARTIMENTOS DEPENDENTES DE Nº DE UTILIZADORES

Neste capítulo pretende-se uma aproximação ao dimensionamento de áreas dependentes do nº de utilizadores:

DESIGNAÇÃO	ÁREA ÚTIL mínima (m²)	Nº UTILIZADORES	OBSERVAÇÕES
SALA DE ESPERA	12	10	-
	16	12	-
	24	20	-
	32	24	-
	40	30	-
	60	40	-
	80	50	-
SALA DE REANIMAÇÃO (URGÊNCIA)	30	1	Área considerada para 1 utente
	50	2	Área considerada para 2 utentes em simultâneo
	60	3	Área considerada para 3 utentes em simultâneo
VESTIÁRIO DE PESSOAL	15	15	Com pelo menos 1 cabine de retrete com lavatório, 2 duches, zona de cacifos e 2 lavatórios além do da cabine.
	20	20	Com pelo menos 2 cabines de retrete com lavatório, 2 duches, zona de cacifos e 2 lavatórios além dos das cabines.
	30	30	Com pelo menos 2 cabines de retrete com lavatório, 3 duches, zona de cacifos e 2 lavatórios além dos das cabines.
	40	40	Com pelo menos 3 cabines de retrete com lavatório, 4 duches, zona de cacifos e 3 lavatórios além dos das cabines.
	60	60	Com pelo menos 4 cabines de retrete com lavatório, 6 duches, zona de cacifos e 4 lavatórios além dos das cabines.
	100	100	Com pelo menos 7 cabines de retrete com lavatório, 10 duches, zona de cacifos e 7 lavatórios além dos das cabines.
SALA DE REUNIÕES	16	10	-
	20	12	-
	24	15	-
	30	20	-
	40	25	-
REFEITÓRIO / RESTAURANTE DE PESSOAL	50	0-30	até 30 utilizadores em simultâneo
	50	31-80	50 m² acrescido de 1,5 m² por cada pessoa acima de 31
	100	81-300	100 m² acrescido de 1,4 m² por cada pessoa acima de 81
	400	301-(...)	100 m² acrescido de 1,3 m² por cada pessoa acima de 81

12. MATRIZ DE PROXIMIDADES

A matriz de proximidades definirá, num diagrama de duas entradas, as relações físicas entre os vários espaços funcionais. Terá de informar sobre as relações de proximidade essenciais e importantes e será dividida preferencialmente por três tipos de proximidade ou níveis:

Nível 1 - Continuidade (vertical ou horizontal)

- Em continuidade horizontal com uma distância a percorrer entre as entradas dos espaços funcionais no máximo até 100 metros e sem atravessamento de outros espaços funcionais OU continuidade vertical conseguida com ligação por elevadores dedicados, sem atravessamento de outros espaços funcionais e com uma distância a percorrer (sem contabilizar o percurso de elevador) no máximo até 100 metros.

Nível 2 - Comunicação fácil

- Com percurso claro entre as entradas dos espaços funcionais (i) sem atravessamento de outros espaços funcionais, (ii) com necessidade de utilização, se aplicável, de apenas 1 núcleo de elevadores e (iii) com uma distância a percorrer (sem contabilizar o percurso vertical de elevador, se aplicável) no máximo até 250 metros.

Nível 3 - Relação logística

- Com existência de percurso entre os espaços funcionais, sem passar pelo exterior, sem atravessamento de outros espaços funcionais e sem circulação em áreas de doentes externos/visitas. No caso das relações logísticas com os Laboratórios estas podem ser conseguidas por tubo pneumático.

Nível 4 - Sem relação

- Quando não é importante estabelecer algum tipo de relação entre espaços funcionais, não têm de ser listadas para não tornar a tabela incompreensível.

Poderão ser apresentadas várias abordagens de diferentes níveis, permitindo a referência às relações entre as várias áreas funcionais, mas também entre os espaços funcionais incluídos em cada área funcional e eventualmente entre os compartimentos incluídos em cada espaço funcional, como por exemplo a casa mortuária que, apesar de pertencer ao laboratório de anatomia patológica, não está adjacente a este e precisa ter uma relação de continuidade com uma entrada exterior.

Este capítulo, que pode figurar como anexo, deve incluir um quadro onde constem as prioridades quanto às principais proximidades entre espaços funcionais, com implicações na funcionalidade dos mesmos, classificadas numa escala de cores/algarismos que corresponde aos diferentes tipos de proximidades explicitados anteriormente.

Esta matriz não deve ser exaustiva, não devendo classificar todas as proximidades entre todos os serviços de uma unidade hospitalar, pois poder-se-á tornar inoperacional quando se trata de todo um hospital, tornando-a inútil e de difícil cumprimento.

Devem ser assinaladas apenas as proximidades mais relevantes e que têm implicação no bom funcionamento dos espaços funcionais e de inter-relações entre os mesmos.

A título de exemplo, inclui-se de seguida uma matriz de proximidades meramente exemplificativa:

Guia para elaboração de programas funcionais

		Áreas Assistenciais:																								Áreas de Suporte Clínico													
		AF1 - Núcleo Materno-Infantil									AF2 - Ambulatório						AF3 - Cirurgia			AF4 - Internamen- to		AF5 - Cuidados intensivos e especiais		AF6 - Urgência	AF7 - SM	AF8 - Oncologia			AF9 - Centro Tecnológico		AF10 - Biomédicas						AF11 - Farmácia	AF2 - URDMUM	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	Consultas externas e exames materno-infantil		1	2	4	2	4	4	4	4	1	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	Hospital de dia médico pediátrico			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	Unidade de procriação medicamente assistida				4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	
4	Internamento pediátrico					1	2	2	2	4	4	2	4	2	2	4	2	2	2	4	4	4	2	4	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	4
5	Internamento ginecologia/obstetrícia						2	4	4	2	4	2	4	4	4	4	2	2	2	1	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	Unidade de cuidados intensivos e intermédios neonatais							2	2	1	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4
7	Unidade de cuidados intensivos e intermédios de pediatria								2	4	4	4	4	4	4	4	1	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4
8	Urgência pediátrica									1	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	2	1	4	4	4	4	1	2	4	4	4	4	2	4	2	4	4
9	Urgência gineco-obstétrica / Bloco de partos										4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	2	4	1	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	Consulta externa											1	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	Gabinetes de exames especiais												2	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	Hospital de dia médico													4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	Centro de hemodiálise														4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	Medicina física e de reabilitação														4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	Central de colheitas															4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4
16	Unidade de cirurgia convencional																	1	2	2	4	1	2	1	4	4	4	4	2	1	4	4	4	2	2	4	4	2	4
17	Unidade cirurgia de ambulatório																		1	2	4	2	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4

Legenda:

- 1

Continuidade Horizontal ou Vertical
- 2

Comunicação Fácil
- 3

Relação Logística
- 4

Sem Relação

13. ESTACIONAMENTOS

A crescente ambulatorização dos cuidados de saúde, que tem tido uma tendência crescente nos últimos anos face à prestação de cuidados em regime de internamento, tem conduzido à alteração de paradigmas vigentes relativos ao dimensionamento de muitas das áreas do hospital.

Apesar das áreas de internamento e do número de camas de internamento se manter elevado e não ter sofrido o decréscimo que se previa, devido a fatores extrínsecos como o envelhecimento da população e prevalência de doenças crónicas, subsistência de camas ocupadas com casos sociais e falta de oferta de cuidados de retaguarda como cuidados paliativos, cuidados continuados e internamento domiciliário, é notório o crescimento dos cuidados de saúde em ambulatório, o que implica a dedicação de grandes áreas das unidades de saúde, com crescente apoio tecnológico e digital.

Por este motivo, o rácio normalmente utilizado para a estimativa do número de lugares de estacionamento necessários, de três lugares por cada cama de internamento, pode ficar aquém das necessidades efetivas da unidade hospitalar. Este rácio é ainda de mais difícil aplicação quando se trata de unidades com uma componente ambulatoria maior e pouco ou sem internamento, como é o caso dos hospitais de proximidade.

No entanto, e uma vez que a tendência natural de evolução futura vai no sentido de uma mobilidade sustentável e de redução das deslocações de automóvel, privilegiando meios de transporte mais ecológicos, considera-se adequada a utilização deste rácio para estimar o número de lugares necessários. Paralelamente ao planeamento do número de lugares de estacionamento necessários à unidade hospitalar e conjuntamente com os respetivos municípios, devem ser planeadas ciclovias e o incremento de transportes coletivos e de formas alternativas de mobilidade, desincentivando o uso do transporte individual por parte dos utentes e profissionais.

13.1. ESTACIONAMENTO DE SUPERFÍCIE

A não ser que a área de terreno o permita, o estacionamento à superfície deve ser desincentivado e deve ser substituído, sempre que possível, por estacionamento subterrâneo. Apesar dos seus custos mais elevados na construção, tem vantagens, quer a nível de impacto visual, quer a nível de minimização de percursos dos utentes e profissionais aos respetivos espaços funcionais da unidade hospitalar.

Os estacionamentos devem ser concebidos em função da localização dos diferentes espaços funcionais projetados ou existentes e articulados com a rede viária e circuitos pedonais.

Uma unidade de saúde deverá ter no mínimo o número de lugares determinado na legislação vigente destinados a pessoas com mobilidade condicionada (PMC), assim como postos de carregamento para veículos elétricos. No entanto, e devido à afluência de um maior número de utentes de mobilidade condicionada que naturalmente ocorre a uma unidade de saúde, devem ser previstos um número mais elevado de lugares para PMC do que os mínimos estipulados no DL 163/2006 de 8 de agosto.

O estacionamento à superfície deve ser sobretudo destinado a parque de estacionamento das urgências, estacionamento de ambulâncias, espaços de estacionamento temporário para tomada e largada de passageiros (*kiss and ride*), pessoas de mobilidade condicionada, garagem da VMER, lugares do serviço de apoio domiciliário, zonas de estacionamento dos cais de cargas/descargas e estacionamento de carrinha funerária junto à casa mortuária.

Os lugares à superfície devem sempre que possível ser cobertos, podendo ser aproveitadas grandes áreas de estacionamento para instalar painéis fotovoltaicos na cobertura dos parques, contribuindo para a melhoria da eficiência energética da unidade hospitalar.

Os lugares de estacionamento à superfície devem ter uma área útil mínima de 11,5 m², pressupondo-os livres de pilares ou outros obstáculos e uma organização perpendicular à via de circulação, com uma largura útil de 2,3 m e um comprimento de 5 m.

Excluem-se os lugares destinados a pessoas de mobilidade condicionada que devem ter uma largura útil de 2,5 m e um comprimento de 5 m, com uma faixa lateral de um metro a todo o comprimento, podendo esta faixa ser partilhada por dois lugares de PMC.

13.2. ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO

O estacionamento subterrâneo deve ser projetado de forma a permitir um acesso eficaz à unidade hospitalar, permitindo a fluidez dos fluxos e a distribuição dos lugares na proximidade dos vários espaços funcionais.

Devem existir acessos ao interior do edifício, mas os acessos desde os diferentes pisos do estacionamento subterrâneo apenas devem permitir aceder à zona na entrada principal e zona da urgência, em zonas controladas, a partir das quais os utentes serão encaminhados para os restantes espaços funcionais.

Devem adicionalmente ser previstos lugares para estacionamento de bicicletas e motociclos.

A área a prever por lugar de estacionamento não deve ter área mínima inferior a 12 m², considerando uma largura útil de lugar de 2,40 m e um comprimento de 5 m.

Excluem-se os lugares destinados a pessoas de mobilidade condicionada que devem ter uma largura útil de 2,5 m e um comprimento de 5 m, com uma faixa lateral de um metro a todo o comprimento, podendo esta faixa ser partilhada por dois lugares de PMC. Estes lugares destinados a PMC devem ser localizados junto dos acessos verticais à unidade hospitalar, minimizando o percurso dos utentes.

14. BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA

Para a elaboração do presente documento foram consultados os Programas Funcionais dos últimos hospitais construídos ou procedimentos concursais em curso, nomeadamente os Programas Funcionais do Hospital de Lisboa Oriental, Hospital de Loures, Hospital de Braga, Hospital de Vila Nova de Gaia/Espinho, Hospital do Seixal e Hospital de Cascais.

MENDONÇA, Cecília- Como nasce um hospital- do pensamento ao funcionamento- Uzina Books 2022

IHFG -International Health Facility Guidelines- Part B – Health Facility Briefing & Design including Functional Planning Units. Version 5 Sep 2017

AIA- The American Institute of Architects- Guidelines for Design and Construction of Hospital and Health Care Facilities, 2005

FAJARDO ROMERO, E. - Programas arquitectónicos de centros hospitalários de nível local -Hospital 2000 Vol I

REDSHAW, Maggie Design for health-The impact of a new hospital environment on children, families and staff- NHS estate, 2004

ACSS, 2022. RETEH Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar- Administração Central do Sistema de Saúde.

ACT Government- CANBERRA HOSPITAL Master Plan 2021–2041 Australian Capital Territory, Canberra, 2021

Ministère de la Santé et des Solidarités - Nouvelles Organisations et Architectures Hospitalières

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, IP
Parque de Saúde de Lisboa | Edifício 16, Avenida do Brasil, 53
1700-063 LISBOA | Portugal
Tel Geral (+) 351 21 792 58 00 Fax (+) 351 21 792 58 48